CODE 12 — SOIN COMMUNAUTAIRE, FRAGILITÉS FONCTIONNELLES ET SANTÉ COMMUNAUTAIRE

Version : V1.4
Alignement déclaré : Constitution V.30 ; Code 1 V1.7 ; Code 2 V1.5 ; Code 3 V1.5 ; Code 4 V1.5 ; Code 5 V1.4 ; Code 6 V1.6 ; Code 7 V1.7 ; Code 8 V1.4 ; C.1-Annex A V1.4 ; Code 9 V3.1 ; Code 10 V1.5 ; Code 11 V1.4 ; Code 13 V1.5 ; Code 14 V1.3 ; Code 15 V1.4 ; Code 16 V1.4.

Art. 1 — Objet, définitions et champ de compétence

1. Le présent Code régit l'organisation du soin communautaire, la prise en charge des fragilités fonctionnelles, la gestion des espaces et des outils de soin et la programmation du temps nécessaire pour garantir les prestations essentielles. Ces ressources constituent des biens communs d'infrastructure nécessaires à la mise en œuvre du Panier de suffisance, à la protection de la santé et à l'accès au logement.

2. Aux fins du présent Code, on entend par :

   a) **soin communautaire** : l'ensemble des activités de soutien à la vie quotidienne, relationnelle et domestique, d'accompagnement, de soutien éducatif et d'assistance pratique qui ne constituent pas des prestations cliniques ;

   b) **fragilité fonctionnelle** : une condition temporaire ou permanente qui limite l'autonomie de la personne dans l'accomplissement d'une ou plusieurs fonctions essentielles comprises dans les niveaux 1 et 2 du Panier, indépendamment de la présence, de l'absence ou de la qualification d'un diagnostic clinique ;

   c) **Panier soin** : la composante du Panier de suffisance régi par le Code 1 qui comprend le temps minimal de soin, l'accès aux espaces de soin et, lorsque cela est nécessaire, le soutien pour les repas, l'hygiène, l'accompagnement et le repos protégé ;

   d) **espaces de soin** : les espaces et les structures destinés, selon les besoins et la planification territoriale, à la cuisine de soutien aux personnes fragiles, à la buanderie commune, à la petite enfance de zéro à trois ans, au repos protégé, à l'assistance de proximité non clinique et à l'accueil temporaire communautaire ;

   e) **plan individuel de soin** : le document confidentiel qui, sur la base du besoin fonctionnel constaté et dans le respect de la volonté de la personne, détermine les prestations nécessaires, les responsables, la durée prévue et les dates ou conditions de réexamen ;

   f) **Fiche de sécurité de soin** : le document opérationnel qui identifie les risques liés à une activité de soin déterminée et fixe les mesures préventives, les compétences requises, les procédures d'interruption et les modalités de substitution en cas d'indisponibilité d'une ressource essentielle ;

   g) **STV Soin** : la spécification technique contraignante, adoptée conformément au Code 2, qui définit les normes, les quantités minimales, les procédures et les modalités opérationnelles des services régis par le présent Code.

3. Sont des biens communs d'infrastructure inaliénables :

   a) le temps minimal de soin nécessaire pour garantir les niveaux 1 et 2 du Panier ;

   b) les espaces de soin essentiels du Cercle 1 et leurs équipements communs ;

   c) l'inventaire des aides techniques de base et des dispositifs non cliniques destinés au soin communautaire ;

   d) les connaissances essentielles de soin ainsi que les STV et les Fiches de sécurité correspondantes ;

   e) le bilan agrégé du temps de soin.

   La gestion de ces biens ne peut pas entraîner d'appropriation exclusive, de rente ou d'exclusion injustifiée des ayants droit.

4. Le Code 12 régit à titre exclusif, dans le cadre de sa matière, l'organisation du soin communautaire, la constatation de la fragilité fonctionnelle, le Panier soin, le temps de soin et la fonction interne des

espaces de soin. Restent attribués :

a) au Code 6 le diagnostic, les prestations cliniques, la nutrition clinique et les autres actes sanitaires ;

b) au Code 9 la production et la préparation des aliments et la gestion technique et organisationnelle des cantines collectives ;

c) au Code C.1-Annex A la fabrication et la standardisation des aides techniques ;

d) au Code 10 la destination d'usage et la localisation territoriale des espaces ;

e) aux Codes 1, 4 et 14, chacun pour sa matière, les dispositions générales relatives au Panier, aux garanties et à la sécurité.

5. Le présent Code poursuit les objectifs suivants :

a) garantir la continuité des niveaux 1 et 2 du Panier, y compris en présence d'une fragilité fonctionnelle ;

b) empêcher la formation de rentes sur les prestations essentielles de soin ;

c) assurer une répartition équitable, vérifiable et durable du temps de soin ;

d) prévenir l'isolement et le recours injustifié à des formes d'institutionnalisation ;

e) favoriser, lorsque cela est approprié et souhaité par la personne, la récupération ou le maintien de l'autonomie.

Art. 2 — Principes du soin communautaire

1. **Universalité.** Toute personne a droit aux prestations essentielles du Panier soin correspondant aux niveaux 1 et 2, sans que cela soit subordonné à sa contribution individuelle à la CBO et selon les garanties prévues par le Code 1.
2. **Autonomie de la fragilité fonctionnelle.** La fragilité fonctionnelle constitue une condition pertinente aux fins du soin communautaire, distincte du diagnostic clinique. Sa constatation ne requiert pas, en soi, d'évaluation sanitaire. Les actes cliniques restent régis par le Code 6.
3. **Proximité et continuité.** Le soin essentiel est organisé, dans la mesure du possible, au sein du Cercle 1. Les prestations qui requièrent des compétences ou des structures non disponibles localement sont garanties au moyen du réseau fédéré visé à l'article 6.
4. **Priorités et pénurie.** Les priorités générales du Panier sont celles fixées par le Code 1, article 32. En cas d'insuffisance du temps de soin, la réduction porte en premier lieu sur les activités de niveau supérieur, à partir du niveau 5, dans le respect de la hiérarchie du Code 1 et sans porter atteinte aux prestations essentielles des niveaux inférieurs. Dans le cadre des priorités applicables, les décisions tiennent compte de l'urgence, de la gravité du besoin et du risque d'interruption du soin.
5. **Non-accumulation et non-monétisation.** Le temps essentiel de soin n'est ni monétisable ni accumulable individuellement dans une mesure qui retirerait des disponibilités aux autres ayants droit. L'éventuelle limite technique d'accumulation est définie par STV, sur la base de la capacité effective du service et selon des critères publics.
6. **Transparence et confidentialité.** Les inventaires des espaces et des équipements, ainsi que les bilans du temps de soin, sont publiés sous forme agrégée et non identifiante. Les données individuelles nécessaires à la prise en charge sont traitées exclusivement à cette fin, conformément au Code 7, article 2.2.
7. **Réversibilité et réexamen.** Lorsque la fragilité est temporaire, le plan individuel de soin prévoit, s'il y a lieu, un parcours de soutien à l'autonomie et un terme ou une condition de réexamen. Le réexamen ne peut pas entraîner l'interruption automatique des prestations essentielles en l'absence d'une nouvelle évaluation.
8. **Dignité, volonté et proportionnalité.** Les prestations sont organisées dans le respect de la dignité, des préférences et de la volonté de la personne. Les limitations de l'autonomie ne sont admises que dans les cas et avec les garanties prévus par l'ordre juridique applicable et par les Codes compétents.

Art. 3 — Conseil Soin

1. Chaque Cercle 1 institue un Conseil Soin composé de trois à cinq membres, tirés au sort conformément à l’article 12-bis du Code 3. La composition assure des compétences adéquates, au moins de niveau L2 ou L3, dans le domaine du soin communautaire, du soutien à la petite enfance de zéro à trois ans, du grand âge, du handicap et de l’organisation des services de proximité.

2. Les membres sont tirés au sort conformément à l’article 12-bis du Code 3, restent en fonction un an et ne peuvent pas être de nouveau tirés au sort dans le même Conseil avant douze mois à compter de la fin de leur mandat. Le remplacement, la déclaration des conflits d’intérêts et la consignation des décisions au procès-verbal suivent les procédures du Code 3.

3. Le Conseil Soin :

   a) propose et met en œuvre le Panier soin et coordonne les espaces de soin ;

   b) rédige, met à jour et applique les Fiches de sécurité relatives aux activités de soin, à l’hygiène, à l’enfance et à l’accompagnement ;

   c) propose et met à jour les STV Soin selon les procédures du Code 2 ;

   d) programme le bilan agrégé du temps de soin et coordonne les roulements, dans le respect de la liberté individuelle et des compétences des participants ;

   e) organise la formation de niveau L1 pour le soin de base et de niveau L2 pour les activités spécialisées prévues par le Code 5 ;

   f) alimente le Registre des dépendances régi par le Code 15 ;

   g) coordonne les activités avec les Conseils Santé, agroécologique, Habitat, Production et Biodiversité, chacun dans les limites de sa compétence.

4. Les actes du Conseil Soin se répartissent en :

   a) **actes techniques liés**, adoptés en application d’une STV ou d’une Fiche de sécurité en vigueur ;

   b) **propositions et décisions discrétionnaires**, adoptées selon la méthode du consensus et les procédures du Code 3, après publication pendant au moins soixante-douze heures, sauf en cas d’urgence motivée.

   La publication ne comprend pas de données personnelles ni d’informations permettant d’identifier les personnes prises en charge.

5. Les avis obligatoires des Conseils compétents ne transfèrent pas la titularité de la décision. La décision n’est prise conjointement que lorsqu’un Code le prévoit expressément.

6. En l’absence d’une Fiche de sécurité en vigueur, l’activité concernée ne peut pas être engagée ni poursuivie selon des modalités non évaluées. Le Conseil Soin détermine, si possible, une modalité de substitution conforme qui assure la continuité des niveaux 1 et 2. Toute dérogation temporaire est motivée, limitée au strict nécessaire et soumise à vérification.

Art. 4 — Panier soin et constatation de la fragilité fonctionnelle

1. Le Panier soin des niveaux 1 et 2 comprend, selon le besoin constaté :

   a) le temps minimal de soin ;

   b) le soutien pendant le repas, lorsque la personne n’est pas autonome pour s’alimenter ;

   c) l’hygiène assistée ;

   d) l’accompagnement essentiel ;

   e) le repos protégé ;

   f) l’accès à l’espace pour la petite enfance de zéro à trois ans, lorsque cela est nécessaire.

2. Le Panier soin est quantifié principalement en heures d’assistance par personne et par semaine. La STV Panier soin définit au moins les prestations comprises, les normes minimales, les modalités de répartition journalière, les critères d’urgence, les délais de réponse et les procédures de réexamen. Les

normes ne peuvent pas être réduites au point de compromettre les niveaux 1 et 2 du Panier.

3. Le signalement d’un besoin peut être présenté par la personne concernée ou par toute personne qui constate une nécessité de soin. Le signalement :

   a) déclenche l’évaluation fonctionnelle ;

   b) permet, en présence d’un besoin essentiel, l’activation provisoire des prestations nécessaires pour une période maximale de soixante-douze heures, dans l’attente de l’évaluation ;

   c) ne peut pas être utilisé pour engager des traitements cliniques ou pour attribuer un diagnostic.

   En présence d’un risque immédiat pour la vie, la santé ou l’intégrité physique de la personne, les procédures d’urgence des Codes compétents sont activées sans délai.

4. Le Conseil Soin évalue la condition fonctionnelle dans un délai de soixante-douze heures à compter du signalement, sur la base de critères publics contenus dans la STV. L’intervention du Conseil Santé n’est requise que lorsque des compétences sanitaires sont nécessaires ou lorsque des éléments de risque clinique apparaissent. L’évaluation fonctionnelle ne constitue pas un diagnostic et ne peut pas remplacer une évaluation sanitaire prévue par le Code 6.

5. Le plan individuel de soin indique au moins :

   a) le besoin fonctionnel constaté ;

   b) les prestations et la fréquence nécessaires ;

   c) la date de début et la durée prévue ;

   d) le référent chargé de la coordination ;

   e) les délais et les critères de réexamen ;

   f) les modalités de continuité ou de substitution en cas d’indisponibilité du service.

   La personne concernée participe à l’élaboration du plan avec les modalités de communication et de soutien appropriées. Pour une fragilité temporaire, le réexamen a lieu dans un délai de quatre-vingt-dix jours, sauf nécessité de l’avancer.

6. La liste minimale des prestations du Panier soin est approuvée par l’Assemblée sur proposition du Conseil Soin. L’avis obligatoire du Conseil Santé est requis pour les seuls aspects sanitaires. La liste, les normes et les procédures sont publiées dans la STV Panier soin.

7. Les priorités opérationnelles s’appliquent dans le respect du Code 1, article 32, et selon l’ordre suivant, à apprécier en fonction de l’urgence et du besoin individuel :

   a) survie, hygiène essentielle et repos protégé ;

   b) soin de la petite enfance de zéro à trois ans et soutien aux personnes du grand âge en perte d’autonomie ;

   c) convalescence et période qui suit l’accouchement ;

   d) soutien au maintien ou à la récupération de l’autonomie ;

   e) autres prestations de soin.

Art. 5 — Services, temps de soin et coordination avec les autres Codes

1. Chaque Cercle 1 assure l’accès effectif aux services de base suivants, directement ou au moyen d’un réseau partagé :

   a) cuisine de soutien aux personnes fragiles, fonctionnellement coordonnée avec les cantines du Code 9 ;

   b) buanderie commune ;

   c) espace pour la petite enfance de zéro à trois ans ;

   d) espace de repos protégé ;

   e) accompagnement de proximité.

   Les modalités de fourniture sont définies de manière à garantir l’accessibilité, la continuité et la

sécurité.

2. Le Cercle 1 est responsable, de manière collective, de la disponibilité du volume d’heures nécessaire pour garantir les niveaux 1 et 2. La participation individuelle s’effectue selon les disponibilités, les compétences et les règles du Code 3. Aucune contrainte incompatible avec la liberté individuelle, avec la situation de la personne ou avec les compétences requises n’est admise. L’indisponibilité individuelle ne peut pas entraîner la perte du droit de la personne fragile aux prestations essentielles.

3. Le temps de soin est enregistré sous forme agrégée afin de programmer les services, de vérifier la couverture des niveaux 1 et 2 et de repérer les carences. L’enregistrement ne peut pas être utilisé pour profiler les personnes qui reçoivent ou dispensent des soins en dehors des finalités autorisées par le Code 7.

4. Les compétences sont réparties comme suit :

   a) le Code C.1-Annex A régit la fabrication, la réparation et la standardisation des aides techniques ;

   b) le Code 9 régit la production et la préparation des aliments et la gestion technique et organisationnelle des cantines ;

   c) le Code 12 régit l’assistance à la personne fragile pour l’accès et l’accompagnement au repas, la prise assistée des repas, l’hygiène et l’usage quotidien des aides techniques.

   Le présent Code n’attribue pas au Conseil Soin la compétence de produire des aides techniques ou d’organiser la préparation des aliments.

5. Pour les prestations de niveau 4 ou 5, avant de demander de nouvelles ressources, la possibilité de réemploi ou de récupération d’aides techniques, de vêtements et d’espaces est vérifiée, à condition que la solution soit sûre, adaptée au besoin et ne réduise pas la qualité des prestations essentielles.

6. Le droit des personnes âgées et en perte d’autonomie de rester à domicile est garanti, avec un soutien communautaire par roulement inclus dans la CBO, en application de l’article 27 de la Constitution. Les Maisons communes autogérées relèvent du choix de la personne et ne peuvent pas constituer une destination imposée.

Art. 6 — Espaces, réseau fédéré et territoire

1. Chaque Cercle 1 active et maintient les espaces de soin nécessaires, directement ou au moyen d’accords de réseau. Les espaces sont accessibles, peuvent être divisés en zones fonctionnelles et disposent de Fiches de sécurité à jour pour les activités effectivement exercées.

2. La destination d’usage et la localisation des espaces sont régies par le Code 10. Le Code 12 régit la fonction de soin exercée en leur sein, sans modifier la destination territoriale ni les contraintes relevant de la compétence du Code 10.

3. La Confédération assure au moins une structure fédérée dotée de compétences avancées pour chaque bassin composé de trois ou quatre Cercles 1. La planification détermine la taille du bassin, les services disponibles et les modalités d’accès. Les structures garantissent, selon les besoins, des compétences de pédiatrie sociale, un soutien au handicap complexe et des espaces temporaires d’urgence.

4. L’accès aux structures fédérées s’effectue selon des critères publics, non discriminatoires et compatibles avec l’urgence du besoin. L’inventaire des ressources est partagé entre les Cercles concernés et mis à jour selon les modalités fixées par la STV.

5. La mesure des services est limitée aux données nécessaires à la sécurité, à la programmation du temps de soin et à la vérification du Panier soin. Les données individuelles éventuellement nécessaires à la prise en charge restent confidentielles ; les indicateurs publics sont agrégés et ne permettent pas le profilage. Le profilage comportemental individuel non nécessaire aux finalités du présent Code est interdit, conformément au Code 7, article 2.2.

Art. 7 — Sécurité, formation et droit d’interruption

1. Aucune activité destinée à des personnes fragiles ne peut être engagée sans une Fiche de sécurité en

vigueur et adaptée à l’activité. La Fiche est validée par le Conseil Soin, après avis obligatoire du Conseil Santé pour les aspects relatifs au risque sanitaire, à l’hygiène et aux repas assistés. La titularité de la validation reste au Conseil Soin, sauf dans les cas où un Code prévoit expressément une validation conjointe.

2. Les Fiches de sécurité de soin sont coordonnées avec les dispositions du Code 1, article 27, et du Code 14, chacun pour sa compétence. En cas de risque sanitaire ou clinique, les procédures du Code 6 s’appliquent.

3. Les dispositifs essentiels au soin communautaire sont gérés dans l’Entrepôt Santé régi par le Code 6. Ils sont mis à disposition sans frais pour la personne concernée, entretenus et enregistrés dans l’inventaire correspondant. L’indisponibilité d’un dispositif essentiel entraîne la suspension de la seule activité qui ne peut pas être exercée en sécurité ; le Conseil Soin active, lorsque cela est techniquement possible, une fonction de substitution conforme pour assurer la continuité des niveaux 1 et 2.

4. La formation minimale requise est la suivante :

   a) niveau L1 pour l’accès opérationnel aux espaces accueillant des personnes fragiles et pour les activités de soin de base ;

   b) niveau L2 pour les activités qui concernent l’enfance, les personnes du grand âge en perte d’autonomie ou les personnes en situation de handicap, selon la classification du Code 5 ;

   c) niveau L3 pour la conception des activités de soin, la rédaction des STV et les fonctions de validation prévues par le présent Code.

5. Toute personne qui constate un risque immédiat pour une personne fragile interrompt l’activité concernée, prend les mesures urgentes de protection autorisées et informe sans délai le Conseil Soin et les autres Conseils compétents. L’interruption effectuée de bonne foi pour prévenir un dommage ne peut entraîner ni représailles ni préjudice pour l’auteur du signalement.

Art. 7-bis — Protection des mineurs et des personnes temporairement incapables

1. En cas de violence, de négligence grave ou de préjudice au détriment d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger, le Conseil Soin active sans délai un parcours de protection, en application de l’article 26.3 de la Constitution. Le parcours comprend la mise en sécurité, l’écoute et, si nécessaire, l’accueil temporaire auprès de personnes de confiance ou dans un espace protégé.

2. Le fait est signalé au Cercle de garantie pour les procédures du Code 4. Les signalements dans le Réseau sont limités aux informations nécessaires à la protection. Pendant la transition, l’article 37 du Code 4 s’applique.

3. La séparation d’un mineur de son Cercle 0 n’est admise qu’à titre de mesure temporaire de protection, lorsque le mineur ne peut pas être mis en sécurité en restant dans le Cercle 0. Elle est ordonnée :

   a) en présence d’un danger immédiat, en application de l’article 34, alinéa 1, du Code 4 ;

   b) dans les autres cas de violence, de négligence grave ou de préjudice, par le Cercle de garantie sur proposition motivée du Conseil Soin, après avoir entendu le mineur et, sauf si cela l’expose à un danger, les personnes qui en ont la responsabilité de soin.

La séparation est communiquée sans délai au Tribunal de garantie, qui la valide, la modifie ou la révoque dans un délai de vingt-quatre heures ; à défaut de validation, elle prend fin. Le mineur est accueilli, si possible, auprès de personnes de sa confiance. La validation indique qui prend, pendant la séparation, les décisions quotidiennes et donne le consentement aux soins en application de l’article 2-ter du Code 6. La séparation validée dure jusqu’à la décision de l’alinéa 3-bis et cesse avec elle. L’article 34, alinéa 3, du Code 4 ne s’applique pas.

3-bis. Dans un délai de trente jours à compter de la validation, le Tribunal de garantie prend la décision stable sur la garde du mineur, après avoir entendu le mineur, assisté de la personne de confiance prévue par l’article 31.5 de la Constitution, les personnes qui en ont la responsabilité de soin, avec les garanties

de l’article 25, alinéa 4, du Code 4, et le Conseil Soin. Le délai peut être prolongé une seule fois, d’au plus trente jours supplémentaires, par une décision motivée, lorsqu’un élément nécessaire ne peut pas être obtenu plus tôt, comme une évaluation sanitaire du mineur. À l’échéance, le Tribunal statue en l’état du dossier ; si la décision n’est pas adoptée, la séparation prend fin. Compte tenu de la volonté du mineur selon son âge et sa maturité, il ordonne :

a) le retour dans le Cercle 0, le cas échéant avec un parcours de soutien ; ou

b) uniquement lorsque le retour exposerait le mineur à une violence, à une négligence grave ou à un préjudice qu’un parcours de soutien ne peut pas éviter, la garde par des personnes qui assument la responsabilité de soin en application de l’article 24.3 de la Constitution, en indiquant si cette responsabilité reste partagée avec les personnes qui l’exerçaient ou est suspendue pour elles, et comment les relations avec elles sont maintenues, sauf si cela nuit au mineur.

La décision est réexaminée par le Tribunal au moins tous les six mois et à tout moment à la demande du mineur ou des personnes qui avaient la responsabilité de soin. Elle peut faire l’objet du réexamen de l’article 35, alinéa 2, du Code 4. Le présent alinéa s’applique aussi à la décision sur le lieu et les personnes avec qui vivent les enfants mineurs de la personne qui cesse d’être membre en application de l’article 29, alinéa 6-bis, du Code 4 ; la décision est prise avant que la cessation ne prenne effet et ne requiert pas la séparation de l’alinéa 3. Dans ce cas, la cessation ne constitue pas à elle seule une violence, une négligence grave ou un préjudice au sens de la lettre b), et le Tribunal peut aussi décider que le mineur vive avec la personne sur la parcelle attribuée, avec le logement, le Panier et les services qui lui reviennent en tant que membre.

3-ter. Pendant la transition, la séparation contre la volonté des personnes qui ont la responsabilité de soin et les décisions de l’alinéa 3-bis relèvent des autorités compétentes de l’État, en application de l’article 37 du Code 4. Le Conseil Soin signale le cas, soutient le mineur et collabore à son accueil.

4. Toute personne peut désigner à l’avance un représentant pour le cas où elle deviendrait incapable, y compris au moyen des directives anticipées prévues par l’article 8-bis du Code 6.

5. À défaut de désignation et en cas d’urgence, le Cercle de garantie nomme dans un délai de vingt-quatre heures un représentant temporaire, choisi dans l’ordre parmi les personnes du Cercle 0 indiquées par la personne, sa personne de confiance et une personne tirée au sort ayant une compétence L2 en matière de soin et exempte de conflit d’intérêts. La charge dure au plus trente jours et est renouvelable par décision motivée jusqu’à la nomination du représentant stable prévue par l’article 2-ter, alinéa 5, du Code 6, que le Cercle de garantie demande au Tribunal de garantie lorsque l’incapacité dure ou devrait durer plus de soixante jours.

6. Le représentant décide selon la volonté exprimée ou présumée de la personne et, à défaut, selon son intérêt supérieur. La charge prend fin lorsque la personne recouvre sa capacité.

Art. 8 — Registre des dépendances du soin

1. Le Conseil Soin alimente le Registre des dépendances régi par le Code 15, en indiquant au moins :

   a) **dépendances matérielles**, relatives à des aides techniques, des dispositifs ou des espaces non disponibles dans la Confédération, disponibles seulement au-delà du seuil temporel critique défini dans la STV ou non remplaçables localement ;

   b) **dépendances de compétences**, relatives à des compétences de niveau L2 ou L3 non disponibles dans le bassin visé à l’article 6, alinéa 3 ;

   c) **dépendances extérieures**, relatives à des services de soin extérieurs à la Confédération nécessaires pour garantir la continuité des niveaux 1 et 2.

2. Pour chaque dépendance critique, le Registre indique :

   a) la ressource ou la compétence manquante ;

   b) le service et les niveaux du Panier concernés ;

   c) le responsable du plan de réduction de la dépendance ;

   d) les mesures temporaires de continuité et d’atténuation du risque ;

e) le terme final prévu pour le dépassement de la dépendance ou pour une nouvelle évaluation motivée.

3. Le plan de sortie doit prévoir un terme final certain. Si le dépassement n’est pas techniquement réalisable dans ce délai, le Conseil Soin propose une révision motivée du plan et des mesures de continuité ; la révision ne peut pas se borner à proroger la dépendance sans indiquer d’interventions ni de responsabilités.

4. Chaque année, un audit fédéré sur l’autonomie du soin est réalisé par des membres L3 indépendants, tirés au sort conformément à l’article 36 du Code 4. L’audit évalue également la couverture effective des niveaux 1 et 2 et le respect de la confidentialité.

Art. 9 — Interdictions, garanties et recours

1. Il est interdit :

   a) de tirer des rentes du Panier soin des niveaux 1 et 2, des espaces essentiels, du temps minimal de soin ou des dispositifs essentiels ;

   b) de subordonner à un paiement ou à une licence exclusive l’accès aux STV vitales et aux Fiches de sécurité ;

   c) de réserver à titre exclusif ou d’accumuler du temps de soin, des espaces ou des aides techniques au-delà des limites techniques, lorsque cela réduit la disponibilité pour d’autres ayants droit ;

   d) de refuser ou de suspendre une prestation essentielle du Panier soin à titre de sanction ;

   e) de transférer à des acteurs extérieurs le contrôle des espaces de soin essentiels ;

   f) d’utiliser des données sur la fragilité fonctionnelle à des fins de profilage ou à des fins autres que la prise en charge et les finalités techniques expressément autorisées par le Code 7 ;

   g) d’ordonner l’institutionnalisation forcée d’une personne, sauf placement temporaire strictement nécessaire face à un risque immédiat, adopté dans les conditions et avec les garanties de l’article 8, alinéas 4 à 10, du Code 6 ; pour les mineurs, l’article 7-bis, alinéa 3, s’applique. Les éventuels traitements sanitaires restent régis par le Code 6 et par les garanties correspondantes.

2. Les violations de l’alinéa 1 constituent des violations substantielles. La constatation, les mesures conservatoires, la suspension ou la désactivation de la fonction et les recours sont décidés conformément au Code 4. Le Conseil Soin documente les faits et active les procédures prévues, sans se substituer aux organes compétents pour la constatation ou pour l’application des recours.

3. La suspension ou la désactivation d’une fonction non conforme ne peut pas interrompre les prestations des niveaux 1 et 2 lorsqu’il est possible de les garantir au moyen d’une fonction de substitution techniquement conforme. En cas de risque immédiat, les mesures urgentes prévues par les Codes compétents s’appliquent, avec activation simultanée de la continuité de l’assistance dans la mesure du possible.

4. La personne concernée ou quiconque justifie d’un intérêt qualifié peut former un recours auprès de la Garantie conformément au Code 4, dans un délai de quatorze jours à compter de la communication de la décision ou de la connaissance effective de la violation. Le recours peut porter sur des vices de procédure, un caractère manifestement déraisonnable sur le plan technique, une discrimination ou une disproportion. Le recours ne suspend pas automatiquement les mesures urgentes nécessaires pour prévenir un dommage, sauf décision contraire de l’organe compétent.

Art. 10 — Mise en œuvre, coordination et primauté

1. Le présent Code se coordonne, pour leurs matières respectives, avec :

   a) le Code 1, articles 27 et 32, pour les Fiches de sécurité et l’ordre de priorité du Panier ;

   b) le Code 2, pour les STV ;

   c) le Code 3, pour les délibérations et la méthode du consensus ;

   d) le Code 4, pour la Garantie et les recours ;

e) le Code 5, pour les niveaux de compétence et la formation ;

f) le Code 6, pour la santé, les prestations cliniques et l’Entrepôt Santé ;

g) le Code 7, article 2.2, pour les règles relatives au réseau et aux données ;

h) le Code 8, pour les ressources en eau éventuellement nécessaires aux espaces de soin ;

i) le Code C.1-Annex A, pour les aides techniques ;

j) le Code 9, pour la production alimentaire et les cantines ;

k) le Code 10, pour la destination territoriale des espaces ;

l) les Codes 13, 14 et 15, pour leurs matières respectives, y compris la biodiversité, la sécurité et le Registre des dépendances.

2. Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur, chaque Cercle 1 :

a) recense, selon des modalités respectueuses de la confidentialité, les besoins fonctionnels pertinents pour la continuité des niveaux 1 et 2 ;

b) recense les espaces de soin, les équipements et les disponibilités en temps ;

c) active le Panier soin minimal au moyen d’une STV provisoire et de Fiches de sécurité minimales.

3. Dans un délai de douze mois à compter de l’entrée en vigueur, chaque Cercle 1 :

a) institue le Conseil Soin ;

b) garantit l’accès aux espaces de soin minimaux ;

c) active l’inventaire fédéré des aides techniques ;

d) adopte les STV définitives pour les niveaux 1 et 2 ;

e) désigne son propre nœud du Réseau Soin fédéré.

En présence de chevauchements documentés des charges transitoires relatives aux Codes 9, 10 et 12, l’Assemblée peut accorder une prorogation motivée, pour une période n’excédant pas six mois. La prorogation indique les activités restant à achever, les responsables et les échéances intermédiaires et ne peut pas suspendre la garantie des niveaux 1 et 2.

4. Les fonctions existantes qui se révèlent contraires à l’article 9 sont soumises sans délai à vérification conformément au Code 4. Dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en vigueur, doit être engagé, pour chaque fonction concernée, un parcours documenté de mise en conformité ou, si la mise en conformité est techniquement impossible, la procédure de désactivation prévue par le Code 4. Le plan désigne la fonction de substitution et un terme final certain. La désactivation d’une fonction qui garantit les niveaux 1 et 2 n’intervient qu’après l’activation de la substitution, sauf mesures urgentes nécessaires pour faire face à un risque immédiat, adoptées avec les garanties du Code 4.

5. En cas de chevauchement normatif, chaque Code prévaut dans les seules limites de la matière qui lui est attribuée :

a) le Code 12 pour l’organisation du soin communautaire, la constatation de la fragilité fonctionnelle, le Panier soin et la fonction interne des espaces de soin ;

b) le Code 6 pour le diagnostic, les prestations cliniques, la nutrition clinique et les risques sanitaires ;

c) le Code 9 pour la production et la préparation des aliments et la gestion technique et organisationnelle des cantines ;

d) le Code 10 pour la destination d’usage et la localisation territoriale des espaces ;

e) le Code C.1-Annex A pour la fabrication et la standardisation des aides techniques ;

f) le Code 14 pour les aspects de sécurité relevant de sa compétence.

La primauté est limitée à l’objet spécifique et n’entraîne pas l’absorption des compétences attribuées aux autres Codes. En cas de conflit qui ne peut être résolu par une interprétation coordonnée, les organes compétents définissent une solution conjointe selon les procédures de l’ordre juridique, en assurant entre-temps les mesures de protection nécessaires et la continuité des niveaux 1 et 2.